Wat zijn de meest voorkomende calamiteiten in Nederland?

In de zorg kunnen er situaties ontstaan die niemand wil meemaken: een ernstige fout, een onverwacht overlijden of een incident dat grote gevolgen heeft voor een patiënt. Dit soort gebeurtenissen noemen we calamiteiten. Ze komen vaker voor dan veel mensen denken, en ze raken zorgverleners en patiënten diep. Gelukkig bestaat er een duidelijk kader voor hoe zorgorganisaties met calamiteiten in de zorg (https://dokh.nl/calamiteiten/) moeten omgaan, van melding tot onderzoek.

In dit artikel beantwoorden we de meest gestelde vragen over calamiteiten in Nederland. Of je nu werkzaam bent als huisarts, praktijkmanager of zorgcoördinator: inzicht in dit onderwerp helpt je om beter voorbereid te zijn en de kwaliteit van zorg te bewaken.

Wat is een calamiteit in de zorg precies?

Een calamiteit in de zorg is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die heeft geleid tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt. Dit is de wettelijke definitie zoals vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het gaat dus niet om bijna-incidenten of kleine fouten, maar om situaties met daadwerkelijk ernstige uitkomsten.

Belangrijk om te begrijpen is dat een calamiteit niet per se het gevolg is van nalatigheid of een fout van een individuele zorgverlener. Soms spelen systeemfouten, communicatieproblemen of organisatorische tekortkomingen een rol. De definitie draait om de ernst van de uitkomst voor de patiënt, niet om de intentie van de zorgverlener.

Wat zijn de meest voorkomende calamiteiten in de eerstelijnszorg?

In de eerstelijnszorg komen calamiteiten het vaakst voor op het gebied van diagnostiek, medicatie en communicatie. Denk aan gemiste of vertraagde diagnoses, fouten bij het voorschrijven of afleveren van medicijnen, en miscommunicatie tussen zorgverleners onderling of met de patiënt.

Andere veelvoorkomende calamiteiten in de eerstelijn zijn:

- Vertraagde doorverwijzing naar een specialist bij ernstige aandoeningen
- Fouten bij het uitvoeren van kleine chirurgische ingrepen of wondverzorging
- Onvoldoende opvolging van uitslagen van laboratoriumonderzoek
- Communicatiefouten bij de overdracht van patiëntinformatie tussen zorgverleners
- Medicatiefouten, zoals verkeerde doseringen of gevaarlijke combinaties van geneesmiddelen

De eerstelijn heeft te maken met een enorm volume aan patiëntcontacten, wat de kans op incidenten vergroot. Dat maakt structurele aandacht voor veiligheid en kwaliteit in huisartsenpraktijken en aanverwante settings des te belangrijker.

lke calamiteiten komen het meest voor bij huisartsenpraktijken?

Bij huisartsenpraktijken zijn gemiste diagnoses en medicatiefouten de meest voorkomende categorieën van calamiteiten. Een huisarts ziet dagelijks tientallen patiënten met uiteenlopende klachten, wat de kans op het missen van een ernstige aandoening vergroot, zeker bij klachten die in eerste instantie onschuldig lijken.

Specifieke voorbeelden die regelmatig terugkomen in de huisartsenpraktijk zijn het niet tijdig herkennen van een hartinfarct, een hersenbloeding of sepsis. Ook fouten in de triagefase, bijvoorbeeld door doktersassistenten die onvoldoende zijn toegerust voor complexe situaties, kunnen leiden tot ernstige gevolgen. Daarnaast spelen administratieve fouten, zoals het verkeerd registreren van allergieën of medicatiegegevens, een rol bij calamiteiten in de praktijkvoering.

Wat zijn de oorzaken van calamiteiten in de zorg?

Calamiteiten in de zorg ontstaan zelden door één enkele oorzaak. Vrijwel altijd is er sprake van een samenloop van factoren, ook wel het ‘Zwitsersekaasmodel’ genoemd: meerdere lagen van bescherming falen tegelijkertijd, waardoor een incident kan plaatsvinden.

De meest voorkomende oorzaken zijn:

- **Communicatiefouten:** gebrekkige overdracht van informatie tussen zorgverleners of naar de patiënt
- **Werkdruk en tijdsdruk:** te weinig tijd per patiënt vergroot de kans op fouten
- **Onvoldoende kennis of vaardigheden:** zorgverleners die niet up-to-date zijn met richtlijnen of protocollen
- **Systeemfouten:** gebrekkige processen, onduidelijke taakverdeling of falende ICT-systemen
- **Onvoldoende follow-up:** uitslagen of signalen die niet tijdig worden opgevolgd

Het begrijpen van deze oorzaken is essentieel om toekomstige calamiteiten te voorkomen. Een goede calamiteitenanalyse kijkt daarom altijd verder dan het handelen van de individuele zorgverlener.

Wanneer moet een calamiteit gemeld worden bij de IGJ?

Een calamiteit moet bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) worden gemeld zodra er sprake is van een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die heeft geleid tot de dood of ernstige schade bij een patiënt. De melding moet zo snel mogelijk worden gedaan, in de praktijk bij voorkeur binnen enkele dagen na het incident.

Niet elk incident hoeft bij de IGJ gemeld te worden. Bijna-incidenten of minder ernstige situaties vallen buiten de meldplicht, maar moeten intern wel worden geregistreerd en besproken. De IGJ beoordeelt na een melding of extern onderzoek noodzakelijk is, of dat de zorginstelling zelf een intern calamiteitenonderzoek uitvoert en de bevindingen rapporteert. Zorgaanbieders zijn verplicht om transparant te zijn over calamiteiten en de patiënt of diens naasten hierover te informeren.

Hoe verloopt een calamiteitenonderzoek in de praktijk?

Een calamiteitenonderzoek verloopt in de meeste gevallen via een vaste structuur: de zorgorganisatie stelt een onderzoeksteam samen, verzamelt relevante informatie, analyseert de toedracht en formuleert verbetermaatregelen. Het doel is niet om een schuldige aan te wijzen, maar om te begrijpen wat er is misgegaan en hoe herhaling kan worden voorkomen.

De stappen in een calamiteitenonderzoek zijn doorgaans als volgt:

1. Melding van de calamiteit intern en, indien van toepassing, bij de IGJ
2. Samenstellen van een onafhankelijk of intern onderzoeksteam
3. Verzamelen van dossiers, verklaringen en overige relevante informatie
4. Analyseren van de oorzaken met behulp van een erkende methode, zoals de PRISMA-methode
5. Opstellen van een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen
6. Implementeren van verbetermaatregelen en evalueren van de effecten

Een onafhankelijk calamiteitenonderzoek geeft meer geloofwaardigheid aan de conclusies en biedt zorgorganisaties de zekerheid dat het proces zorgvuldig en objectief is verlopen. Dit is zowel voor de betrokken zorgverleners als voor de patiënt en diens naasten van groot belang.

Hoe wij helpen bij calamiteitenonderzoek

Als onafhankelijke nascholingsorganisatie en erkende geschilleninstantie staan wij klaar om zorgorganisaties te ondersteunen bij het zorgvuldig afhandelen van calamiteiten. Wij bieden concrete hulp op meerdere vlakken:

- Het uitvoeren van onafhankelijke calamiteitenonderzoeken voor huisartsenpraktijken, huisartsenposten en verloskundigenpraktijken
- Begeleiding bij het opstellen van rapportages die voldoen aan de eisen van de IGJ
- Ondersteuning bij het formuleren en implementeren van verbetermaatregelen
- Nascholingen gericht op patiëntveiligheid en het voorkomen van calamiteiten
- Klachtenregeling en geschillenbeslechting als onderdeel van een breed kwaliteitskader

Wij geloven dat transparantie en leren van fouten de zorg beter maken voor iedereen. Wil je weten hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen bij een calamiteitenonderzoek of klachtenregeling (https://dokh.nl/calamiteiten/)? Neem dan contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een calamiteit, een incident en een bijna-incident?

Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis die daadwerkelijk heeft geleid tot de dood of ernstige schade bij een patiënt, en valt onder de meldplicht van de Wkkgz. Een incident is een ongewenste gebeurtenis die schade heeft veroorzaakt, maar niet per se van ernstige aard. Een bijna-incident (ook wel 'near miss' genoemd) is een situatie waarbij een fout op tijd werd onderkend en gecorrigeerd, zodat de patiënt geen schade heeft ondervonden. Bijna-incidenten hoeven niet bij de IGJ gemeld te worden, maar moeten intern wel worden geregistreerd via een VIM-systeem (Veilig Incident Melden), omdat ze waardevolle leermomenten bieden.

Wat moet ik als zorgverlener doen in de eerste uren na een calamiteit?

In de eerste uren na een calamiteit zijn drie stappen cruciaal: zorg eerst voor de directe veiligheid en opvang van de betrokken patiënt en diens naasten, informeer hen zo snel mogelijk eerlijk en transparant over wat er is gebeurd, en meld de calamiteit intern bij de verantwoordelijke leidinggevende of kwaliteitsfunctionaris. Zorg er daarnaast voor dat relevante documentatie, zoals het patiëntdossier en eventuele logbestanden, veiliggesteld wordt zonder dat er wijzigingen worden aangebracht. Het is ook belangrijk om aandacht te hebben voor de emotionele impact op betrokken zorgverleners, de zogenaamde 'tweede slachtoffers'.

Kan een calamiteitenmelding juridische gevolgen hebben voor de betrokken zorgverlener?

Een calamiteitenmelding bij de IGJ is primair bedoeld voor kwaliteitsverbetering en heeft op zichzelf geen directe juridische gevolgen voor de individuele zorgverlener. De IGJ richt zich in haar onderzoek op systeemfouten en organisatorische verbeterpunten, niet op het aanwijzen van een schuldige. Het is echter mogelijk dat informatie uit een calamiteitenonderzoek in een later stadium wordt gebruikt in een tuchtrechtelijke of civielrechtelijke procedure, al is dit in de praktijk niet de primaire uitkomst. Het transparant melden en zorgvuldig afhandelen van een calamiteit werkt in de meeste gevallen juist in het voordeel van de zorgverlener.

Hoe betrek je de patiënt of diens naasten bij het calamiteitenonderzoek?

Patiënten of hun naasten hebben het recht om geïnformeerd te worden over de uitkomsten van een calamiteitenonderzoek, en in toenemende mate worden zij ook actief betrokken bij het onderzoeksproces zelf. Dit kan door hen in een vroeg stadium te informeren over het verloop van het onderzoek, hun perspectief en vragen mee te nemen in de analyse, en hen de bevindingen persoonlijk toe te lichten na afronding. Een open en empathische communicatie met naasten draagt bij aan herstel van vertrouwen en is bovendien wettelijk verplicht vanuit de Wkkgz. Veel zorgorganisaties schakelen hierbij een onafhankelijke gespreksleider of patiëntvertrouwenspersoon in.

Hoe voorkom ik als praktijkmanager dat een calamiteit zich herhaalt?

Herhaling voorkomen begint bij het daadwerkelijk implementeren van de verbetermaatregelen die uit het calamiteitenonderzoek zijn voortgekomen, en het evalueren of deze maatregelen in de praktijk ook effect hebben. Praktische stappen zijn onder meer het aanscherpen van protocollen, het organiseren van gerichte nascholing voor medewerkers, het verbeteren van overdrachtsprocessen en het structureel bespreken van incidenten en bijna-incidenten in teamverband. Een cultuur van openheid en veilig melden is daarbij de belangrijkste randvoorwaarde: medewerkers moeten zonder angst voor sancties fouten en risico's kunnen signaleren.

W als een zorgverlener het niet eens is met de conclusies van het calamiteitenonderzoek?

…trokken zorgverlener het niet eens is met de conclusies of bevindingen van het calamiteitenonderzoek, heeft hij of zij het recht om een fo…mele zienswijze in te dienen voordat het rapport definitief wordt vastgesteld. Het is verstandig om dit schriftelijk en onderbouwd te doen, eventueel met ondersteuning van een juridisch adviseur of beroepsvereniging. Een onafhankelijk uitgevoerd onderzoek biedt in dergelijke situaties meer zekerheid over de objectiviteit van het proces. Bij aanhoudende geschillen over de uitkomsten kan ook een second opinion of een externe toetsing worden aangevraagd.

Zijn kleine huisartsenpraktijken ook verplicht een calamiteitenonderzoek uit te voeren?

Ja, de meldplicht en de verplichting tot het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek gelden voor alle zorgaanbieders die onder de Wkkgz vallen, ongeacht de omvang van de praktijk. Ook een solopraktijk of een kleine groepspraktijk is dus verplicht om een calamiteit te melden bij de IGJ en een intern onderzoek uit te voeren. Kleinere praktijken beschikken vaak niet over de interne expertise of capaciteit om dit zelfstandig te doen, waardoor het inschakelen van een onafhankelijke externe partij voor het uitvoeren van het onderzoek en het opstellen van de rapportage een praktische en kwalitatief verantwoorde keuze is.

Gerelateerde artikelen

- Hoe werkt een calamiteitenoefening in een zorginstelling? (https://dokh.nl/blog/hoe-werkt-een-calamiteitenoefening-in-een-zorginstelling/)
- Wat is het doel van een calamiteitenrapportage? (https://dokh.nl/blog/wat-is-het-doel-van-een-calamiteitenrapportage/)
- Wat moet je doen bij een calamiteit? (https://dokh.nl/blog/wat-moet-je-doen-bij-een-calamiteit/)
- Is een aardbeving een calamiteit of een ramp? (https://dokh.nl/blog/is-een-aardbeving-een-calamiteit-of-een-ramp/)
- Welke nascholing draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel? (https://dokh.nl/blog/welke-nascholing-draagt-bij-aan-duurzame-inzetbaarheid-van-zorgpersoneel/)

Robijnstraat 6
1812 RB Alkmaar

Contact met DOKh

T 072 - 527 91 00 (tel:072 - 527 91 00)
→ Optie 1: nascholingen
→ Optie 2: klachten en geschillen
→ Optie 3: calamiteiten en medische expertise
E secretariaat@dokh.nl (mailto:secretariaat@dokh.nl)
E klachtenengeschillen@dokh.nl (mailto:klachtenengeschillen@dokh.nl)
E expertises@dokh.nl (mailto:expertises@dokh.nl)

Snelmenu

Nieuwsbrief (https://dokh.nl/nieuwsbrief/)
Post-MBO (https://dokh.nl/jouw-beroepsgroep/praktijkmanagers/post-mbo/)
Nascholingsabonnement (https://dokh.nl/nascholingsabonnement/)
Klacht & geschil zorgverlener (https://dokh.nl/klachten-geschillen/)
Calamiteit (https://dokh.nl/calamiteiten/)
Ongewenste Omgangsvormen (https://dokh.nl/ongewenste-omgangsvormen/)

Volg ons ook op

in (https://linkedin.com/company/dokh/) f (https://www.instagram.c

Medische expertise (https://dokh.nl/medische-expertise/) Arbobeleid (https://dokh.nl/ongewenste-omgangsvormen/)

Copyright: dokh.nl (https://dokh.nl)

Webdesign: Raadhuis.com (https://www.raadhuis.com/?utm_source=https://dokh.nl&utm_medium=footer&utm_campaign=footerlink)